TOME 05 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Pneumologie

Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP) • 286 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 05 : Pneumologie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 286 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	286 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 05

Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 05 • Pneumologie (286 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

PARTIE 1 — RAPPELS ANATOMIE

PARTIE 2 — SÉMIOLOGIE RESPIRATOIRE

- Chapitre 01 : Dyspnée (203)
- Chapitre 02 : Toux (204)
- Chapitre 03 : Opacités et masses intra-thoraciques (207)
- Chapitre 04 : Hémoptysie (205)
- Chapitre 05 : Syndrome d'apnée du sommeil (110)
- Chapitre 06 : BPCO (209)
- Chapitre 07 : Hypersensibilités (186)
- Chapitre 08 : Asthme, rhinite (188)
- Chapitre 09 : EFR
- Chapitre 10 : HTAP (hors programme)
- Chapitre 11 : Infections broncho-pulmonaires (154)
- Chapitre 12 : Insuffisance respiratoire chronique (208)
- Chapitre 13 : Pneumopathies interstitielles diffuses (210)
- Chapitre 14 : Tumeurs du poumon (309)
- Chapitre 15 : Pneumothorax (360)
- Chapitre 16 : Épanchement pleural (206)
- Chapitre 17 : Maladies respiratoires d'origine professionnelle (184)
- Chapitre 18 : Manifestations respiratoires au cours des connectivites/vascularites

PARTIE 1

RAPPELS ANATOMIE

PARTIE 2

SÉMIOLOGIE RESPIRATOIRE

- Chapitre 01 — Dyspnée (203)
- Définition de la dyspnée
- Perception d'une respiration inconfortable ou pénible ressentie lors de situations diverses (repos ou exercice) qui n'entraînent habituellement aucune gêne.
- Il s'agit d'une sensation qui, comme la douleur, comporte une composante sensorielle transmise par des afférences périphériques jusqu'au cerveau (perçue comme une oppression thoracique ou une inspiration incomplète) et une composante affective et émotionnelle (ressentie comme un désagrément, une anxiété ou une frayeur).
- Il ne s'agit pas simplement d'une modification du rythme respiratoire comme la tachypnée. Un patient peut être tachypnéique sans être dyspnéique ou, à l'inverse, dyspnéique sans être tachypnéique.

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

PARTIE 1 — RAPPELS ANATOMIE

PARTIE 2 — SÉMIOLOGIE RESPIRATOIRE

Chapitre 01 : Dyspnée (203)
Chapitre 02 : Toux (204)
Chapitre 03 : Opacités et masses intra-thoraciques (207)
Chapitre 04 : Hémoptysie (205)
Chapitre 05 : Syndrome d'apnée du sommeil (110)
Chapitre 06 : BPCO (209)
Chapitre 07 : Hypersensibilités (186)
Chapitre 08 : Asthme, rhinite (188)
Chapitre 09 : EFR
Chapitre 10 : HTAP (hors programme)
Chapitre 11 : Infections broncho-pulmonaires (154)
Chapitre 12 : Insuffisance respiratoire chronique (208)
Chapitre 13 : Pneumopathies interstitielles diffuses (210)
Chapitre 14 : Tumeurs du poumon (309)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Pneumologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Cause	Difficulte■ respiratoire lie■e a■ un re■tre■cissement du calibre de la filie■re larynge■e : - Peut concerner 1 des 3 e■tages du larynx : supraglottique, glottique ou sous-glottique - Urgence diagnostique et thérapeutique ■
Triade	Bradypne■e + Inspiratoire + Bruit inspiratoire (stridor ou cornage) = pathognomonique de dyspne■e larynge■e
Voix ? Toux ? Dyspnée ? Dysphagie ?	- Lésion sus-glottique (vestibule laryngé, épiglotte) : voix étouffée/couverte + timbre conservé + dysphagie + sialorrhée - Lésion glottique : altération du timbre + dysphonie - Lésion sous-glottique : timbre/voix conservé + toux rauque « aboyante » - Obstruction sous-glottique ou trachéale : voix normale + dyspnée aux 2 temps
Signes associés	- Dysphagie = obstacle oropharyngé, pharyngolaryngé - Sialorrhée = épiglottite, corps étranger oesophagien - Fausses routes = atteinte pharyngo-laryngée
Tirage	Localisation anatomique du tirage indique un obstacle sus-jacent au tirage : - Si obstacle trachéal : basithoracique - Si obstacle laryngé : sus-claviculaire, intercostal, basithoracique/épigastrique - Si obstacle fosses nasales, cavum ou oropharyngée : sous-angulo-maxillaire, sus-claviculaire, intercostal, basithoracique

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Pneumologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Particularités	Larynx de l'enfant a des caractéristiques propres : - Larynx plus haut et proche du nasopharynx : car l'enfant a une respiration nasale exclusive jusqu'à 6 mois - Larynx est proportionnellement beaucoup plus petit que chez l'adulte (en particulier au niveau de l'anneau inextensible du cartilage cricoïde)
Symptômes	- Bradypnée inspiratoire - Bruit inspiratoire produit par le passage de l'air sur la filière laryngée réduit : -> Soit stridor (aigu) : laryngomalacie -> Soit cornage (rauque) : laryngite sous-glottique - Tirage = dépression inspiratoire des parties molles, sous-jacente à l'obstacle (localisateur) (sus-claviculaire, intercostal, basithoracique/épigastrique témoins d'une origine laryngée) - Modifications du cri/voix si l'obstacle est glottique : peut être associé - Toux quinteuse, rauque : peut être associé
Examen	- Examen difficile, limité à l'examen cervical, examen de la cavité orale et de l'oropharynx - Laryngoscopie au miroir : possible qu'à partir de ≥ 5-6 ans, quasi abandonnée au profit de la nasofibroscopie
Endoscopie	Laryngoscopie per nasofibroscopie : 1. Tube souple de très petit diamètre chez l'enfant, passé par la cavité nasale (± anesthésie locale et/ou MEOPA) 2. Permet examen simple/efficace en consultation ou aux urgences, peut être réalisée dès la naissance
Imagerie	- RX F/P du cou : en 1ère intention, avec rayons peu pénétrants, l'air étant utilisé comme contraste - TDM cervico-thoracique : examen radiologique de référence pour l'étude du larynx - Imagerie peut ne pas être effectuée si inhalation avec dyspnée laryngée (urgence = ablatation du CE)

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 05

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 05 • Pneumologie (286 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (286 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.